Клинические рекомендации

Менингококковая инфекция у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**A39** — Менингококковая инфекция
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.01.2026, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1020_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология и эпидемиология 2

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 4

3.1 Жалобы и анамнез 4

3.2 Физикальное обследование 4

3.3 Лабораторные исследования 4

3.4 Инструментальные исследования 5

3.5 Консультации специалистов 5

3.6 Дифференциальная диагностика 5

4. Лечение 5

4.1 Локализованные формы и носительство 5

4.2 Генерализованные формы 5

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 6

5.1 Профилактика 6

5.2 Показания к госпитализации 6

6. Источник и актуальность 7

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 7

1. Основные положения

- Менингококковая инфекция — острая антропонозная болезнь с воздушно-капельным путём передачи Neisseria meningitidis: интоксикация, поражение слизистой оболочки носоглотки и возможная генерализация в виде менингококкемии и/или гнойного менингита с характерной геморрагической сыпью.
- Менингококковый назофарингит клинически не специфичен: затруднение носового дыхания, скудные выделения из носа, гиперемия и отёк задней стенки глотки. Этиологический диагноз устанавливается по исследованию слизи с задней стенки глотки на менингококк.
- Больные и пациенты с подозрением на генерализованную форму подлежат обязательной экстренной госпитализации в инфекционный стационар с ОРИТ; антибиотик внутривенно вводится **не позднее 1 часа** после поступления.
- **Оториноларингологу**
  1. осмотр оториноларинголога показан всем пациентам с генерализованной формой: возможен назофарингит, при менингите — сенсоневральная тугоухость;
  2. серьёзным осложнением менингита является гнойный лабиринтит и кохлеарный неврит;
  3. дексаметазон при менингите с отёком мозга снижает частоту сенсоневральной тугоухости.
- **Экстренная химиопрофилактика контактных**
  1. ципрофлоксацин: 500 мг внутрь однократно;
  2. рифампицин: 600 мг внутрь каждые 12 часов **2 дня**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Менингококковая инфекция — острая антропонозная инфекционная болезнь с воздушно-капельным путём передачи возбудителя (Neisseria meningitidis), проявляющаяся интоксикацией, поражением слизистой оболочки носоглотки и возможной генерализацией в виде специфической септицемии и/или гнойного менингита с характерными изменениями в спинномозговой жидкости, появлением характерной геморрагической сыпи и реже — с поражением других органов и систем.

2.2 Этиология и эпидемиология

Возбудитель — Neisseria meningitidis, грамотрицательный неподвижный диплококк; в типичных случаях располагается попарно внутри нейтрофилов. Выделяют 12 серогрупп, подавляющее большинство заболеваний вызывают A, B, C, Y, X и W. Менингококки колонизируют носоглотку, вызывая бессимптомное носительство; предшествующая респираторная инфекция, особенно грипп, способствует генерализации.

Эпидемиология

1. источник — больные и носители; наибольшую опасность представляют носители и больные назофарингитом;
2. на одного больного манифестной формой приходится до 2 тыс. носителей; носительство длится в среднем 2–3 недели;
3. у 10–20% инфицированных развивается назофарингит, у 1–2% — генерализованная форма;
4. механизм передачи аспирационный, путь воздушно-капельный; 70% заражений происходит при контакте на расстоянии менее 0,5 м.

2.3 Классификация

Классификация по В. И. Покровскому

1. локализованные формы: менингококковое носительство, острый назофарингит;
2. генерализованные формы: менингококкемия, менингит;
3. сочетанная форма — менингит и менингококкемия;
4. редкие формы: миокардит, пневмония, иридоциклит, артрит, энцефалит, неврит зрительного нерва.

По тяжести течения выделяют лёгкую, среднетяжёлую, тяжёлую и фульминантную (молниеносную) формы.

2.4 Клиническая картина

Инкубационный период — **от 2 до 10 дней**, в среднем 4 дня. Менингококковый назофарингит — наиболее частое проявление инфекции; может предшествовать генерализованной форме (у 30–60% больных).

1. затруднение носового дыхания, скудные выделения из носа, небольшой кашель, головная боль;
2. у половины больных — лихорадка 1–4 суток, чаще субфебрильная;
3. слизистая оболочка передних отделов зева обычного вида, задняя стенка глотки гиперемирована, отёчна, с наложениями слизи; со 2–3-го дня — гиперплазия лимфоидных фолликулов;
4. воспалительные изменения особенно выражены в носоглотке и распространяются на заднюю часть хоан и носовых ходов.

Менингококкемия начинается остро среди полного здоровья или на фоне назофарингита.

1. **среднетяжёлая форма** — температура 38–39 °С, к концу первых — началу вторых суток необильная геморрагическая сыпь до 0,5 см на дистальных отделах конечностей и ягодицах
2. **тяжёлая форма** — температура 39–40 °С с выраженным ознобом, обильная крупная геморрагическая сыпь **в первые 12 часов**, с некрозами, на конечностях, лице и туловище; холодные конечности, снижение АД и диуреза — компенсированный инфекционно-токсический шок

При очень тяжёлом течении начало бурное (40–41 °С), сыпь с некрозами в первые часы, шок может развиться до появления сыпи; без адекватной терапии летальный исход наступает **в течение 1–2 суток**.

Менингит начинается остро: познабливание, головная боль, температура в первые сутки 38,5–39,5 °С.

1. головная боль быстро усиливается, становится распирающей, диффузной, не снимается анальгетиками; тошнота, рвота «фонтаном», гиперестезия кожи;
2. в конце 1-го или на 2-й день — менингеальные симптомы: ригидность мышц затылка, симптомы Брудзинского, Кернига;
3. **через 3–5 суток** без лечения — общемозговой синдром и очаговые симптомы, чаще поражение лицевого и глазодвигательных нервов — признаки отёка-набухания головного мозга;
4. серьёзным осложнением является гнойный лабиринтит и кохлеарный неврит, может появиться шум в ушах.

3. Диагностика

3.1 Жалобы и анамнез

Что уточнить

1. озноб, ломоту в теле, сроки появления и величину лихорадки, реакцию на жаропонижающие;
2. першение и боль в горле, затруднение носового дыхания, скудные выделения из носа, кашель, их давность;
3. сильную головную боль, тошноту и рвоту, повышенную чувствительность кожи;
4. сыпь: сроки появления, локализацию, характер и форму.

Эпидемиологический анамнез

1. контакт с больными генерализованной формой, лихорадящими, с катарально-респираторным синдромом;
2. выезд в регион с повышенной заболеваемостью;
3. нахождение в закрытом коллективе;
4. вакцинация **в последние 3 года**.

3.2 Физикальное обследование

При выраженной интоксикации, сильной головной боли и сыпи выполняется осмотр ротоглотки со шпателем для выявления фарингита и кожи — для выявления экзантемы; оцениваются менингеальные и очаговые симптомы, уровень сознания по шкале Глазго.

Для диагностики инфекционно-токсического шока и его степени определяют гипотермию конечностей, АД, ЧСС, ЧДД, объём и частоту мочеотделения.

3.3 Лабораторные исследования

Всем пациентам с подозрением на генерализованную форму выполняется посев слизи с задней стенки глотки на менингококк: исследование верифицирует этиологический диагноз назофарингита и устанавливает носительство.

При подозрении на менингит или сочетанную форму при поступлении исследуют спинномозговую жидкость; диагностическая спинномозговая пункция выполняется при менингеальных, общемозговых и очаговых симптомах при отсутствии противопоказаний.

Этиологическая диагностика при поступлении

1. посев спинномозговой жидкости на менингококк и крови на стерильность с определением серогруппы и чувствительности;
2. микроскопия спинномозговой жидкости и крови с окраской по Граму — ориентировочный метод;
3. реакция агглютинации латекса в спинномозговой жидкости — экспресс-метод;
4. ПЦР крови и спинномозговой жидкости на ДНК менингококка.

Всем при поступлении выполняются развёрнутый общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, кислотно-основное состояние и газы крови, СРБ и прокальцитонин, коагулограмма.

Генерализованная форма диагностируется клинически, если имеются характерные клинико-лабораторные проявления при отрицательных результатах посевов и ПЦР.

3.4 Инструментальные исследования

1. **КТ или МРТ головного мозга** — при появлении очаговой неврологической симптоматики, затяжном течении менингита без санации спинномозговой жидкости
2. **рентгенография или КТ лёгких** — при симптомах поражения дыхательной системы
3. **ЭКГ и эхокардиография** — всем пациентам с генерализованной формой при поступлении

3.5 Консультации специалистов

Осмотр оториноларинголога показан всем пациентам с генерализованной формой: возможен назофарингит, а при менингите — развитие сенсоневральной тугоухости.

1. **анестезиолог-реаниматолог** — при артериальной гипотензии, цианозе, судорогах, нарушении сознания и дыхания
2. **невролог** — при подозрении на менингит, общемозговой и очаговой симптоматике
3. **хирург** — при интенсивных болях в животе
4. **офтальмолог** — при подозрении на менингит, внутричерепной гипертензии, поражении органа зрения

3.6 Дифференциальная диагностика

1. **назофарингит** — с другими поражениями носоглотки (ОРВИ); предположительный диагноз возможен только при вспышке в коллективе и требует лабораторного подтверждения
2. **менингеальные симптомы на фоне интоксикации** — с другими гнойными, серозными вирусными и туберкулёзным менингитами, с менингизмом при острых лихорадочных заболеваниях

---

4. Лечение

4.1 Локализованные формы и носительство

Для эрадикации носительства и лечения подтверждённых локализованных форм применяют средние терапевтические дозы препаратов, активных в отношении менингококка, внутрь.

1. амоксициллин + клавулановая кислота: 250 мг + 125 мг 3 раза в сутки;
2. цефиксим: 400 мг 1 раз в день;
3. ципрофлоксацин: 500 мг 2 раза в сутки;
4. левофлоксацин: 500 мг 1 раз в сутки.

4.2 Генерализованные формы

Препаратами первого выбора являются цефалоспорины III поколения — цефтриаксон и цефотаксим — в максимальных суточных дозах внутривенно **7–10 дней**.

Контрольная спинномозговая пункция

1. при среднетяжёлом течении — **на 7–10-е сутки**;
2. при тяжёлом течении менингита — **на 3–5–7-й день**.

Цефтриаксон недопустимо применять с растворами, содержащими кальций. Также применяют цефепим, бензилпенициллин, ампициллин, ципрофлоксацин с учётом региональной чувствительности.

Меропенем не является препаратом первой линии: его назначают при вторичных бактериальных осложнениях в ОРИТ с учётом чувствительности и эмпирически при выраженной нейтропении.

Антибиотики при генерализованной форме вводятся только парентерально; внутривенное введение начинают **не позднее 1 часа** после поступления и постановки диагноза: каждый час задержки увеличивает летальность.

На догоспитальном этапе антибиотик вводят только при веских подозрениях на генерализованную форму (клиника с геморрагической сыпью), при обеспеченном сосудистом доступе, тяжёлом прогрессирующем состоянии и невозможности госпитализации **в течение 90 минут**.

При менингите, осложнённом отёком-набуханием головного мозга, вводится дексаметазон 4 мг внутривенно до начала антибактериальной терапии или одновременно с ней. Дексаметазон не влияет на летальность, но снижает частоту сенсоневральной тугоухости.

Генерализованная форма с отёком мозга и/или инфекционно-токсическим шоком лечится в ОРИТ.

При инфекционно-токсическом шоке препаратом первой линии вазопрессорной терапии является норэпинефрин; целевое среднее АД — **более 65 мм рт. ст.**

При лихорадке **выше 38,5 °C** и болевом синдроме применяют ибупрофен, парацетамол, диклофенак, кетопрофен.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Лицам, находившимся в тесном контакте с больным, проводится экстренная химиопрофилактика таблетированными препаратами.

1. ципрофлоксацин: 500 мг внутрь однократно;
2. рифампицин: 600 мг внутрь каждые 12 часов **2 дня**.

В очагах генерализованной формы выявляют больных острым назофарингитом и до начала лечения выполняют им посев слизи с задней стенки глотки на менингококк. Больного генерализованной формой изолируют в отдельном боксе до полного клинического выздоровления.

В межэпидемический период вакцинируют в плановом порядке лиц из групп высокого риска, по эпидемическим показаниям — контактных в очагах генерализованной формы.

Диспансерное наблюдение у инфекциониста — **в течение 12 месяцев**. После выписки от профилактических прививок воздерживаются **3 месяца** при среднетяжёлом и **6 месяцев** при тяжёлом течении, кроме столбнячного анатоксина и вакцины против бешенства.

5.2 Показания к госпитализации

Больные и пациенты с подозрением на генерализованную форму подлежат обязательной экстренной госпитализации в инфекционную больницу или отделение с ОРИТ.

Амбулаторное лечение назофарингита и носительства допускается

1. только при лабораторно подтверждённом диагнозе;
2. при проживании в отдельной благоустроенной квартире без контакта с работниками детских и лечебных организаций;
3. при обеспеченном уходе и противоэпидемическом режиме;
4. при отсутствии признаков генерализованной формы и возможности наблюдения на дому.

Исключение — проживающие в интернатах, отелях, хостелах и пациенты с аллергией на препараты выбора.

Критерии выписки

1. регресс менингеальных симптомов, лихорадки и сыпи;
2. нормализация общего анализа крови;
3. санация спинномозговой жидкости: белок **менее 0,45 г/л**, лимфоцитарный цитоз **ниже 100 в 1 мкл**, глюкоза **выше 2 ммоль/л**, лактат **менее 3,0 ммоль/л**;
4. отрицательные результаты посева спинномозговой жидкости и ПЦР крови.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Менингококковая инфекция»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 23.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	`1020_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Раздел 1.6 указывает, что точный диагноз назофарингита устанавливается только микроскопией мазков с задней стенки глотки, а раздел 2.3 и условия амбулаторного лечения требуют посева (культурального исследования) слизи с задней стенки глотки.